

44 - 02-l'Obstruction nasale - Pr. ROCHDI

Alors maintenant on va passer au traitement de l'obstruction nasale dans le cadre de la partie ORL de la signologie 2. L'obstruction nasale se définit comme une sensation subjective de gêne à l'écoulement des flux aériens dans les fosses nasales. Donc c'est une sensation qui est subjective, elle n'est pas objective, de gêne au passage de l'air au niveau des fosses nasales. C'est un motif de consultation qui est très fréquent, qui peut toucher l'enfant, le jeune, le vieux, l'homme, la femme.

Il peut être unilatéral ou bilatéral et c'est un symptôme qui est très important, qu'il ne faut pas négliger, puisqu'il peut être le seul signe révélateur de certaines pathologies qui sont dangereuses et sérieuses. Alors comment aborder un patient qui se plaint d'une obstruction nasale ? D'abord, il faut commencer par l'anamnèse pour avoir une idée sur la date et le mode de début. Est-ce que c'est un problème qui est chronique ou bien qui est récent, depuis l'enfance ou bien à l'âge adulte ? Est-ce qu'il est intermittent, c'est-à-dire qu'il survient par période ou bien il est permanent ? Est-ce qu'il est uni ou bilatéral ? Est-ce que c'est une obstruction nasale qui s'aggrave de façon très progressive ? Et surtout, est-ce qu'il est un signe accompagnateur ? Par exemple, il n'aurait rien ? Est-ce qu'il est clair ? Est-ce qu'il est purulent ? Est-ce qu'il a une épistaxis ? Il faut toujours se méfier des épistaxis d'une épistaxis unilatérale associée à une obstruction nasale.

Une obstruction nasale unilatérale avec une épistaxis unilatérale, c'est un signe d'alarme. Il faut absolument éliminer un problème tumoral. Est-ce qu'il y a une anosmie, une éposémie associée qui témoigne d'une atteinte diffuse de la vitreuse nasale ? Une algie faciale, décephalée, surtout lorsqu'elles sont récentes, ça oriente vers un problème probablement expansif ou infectieux, en train de se compliquer.

Est-ce qu'il y a un éternuement, un purite nasale ? Et est-ce qu'il y a des signes otologiques associés ? Alors ces signes accompagnateurs avec l'obstruction nasale, il faut essayer de les rattacher, comme on l'a dit la dernière fois dans l'arénorée, à l'unité du lieu et du temps. C'est-à-dire est-ce que ces symptômes, par exemple l'obstruction nasale, l'éternuement, l'arénorée, le purite nasale, est-ce qu'ils sont en rapport avec le changement du lieu, le changement de vie, l'exposition à certains produits ou la manipulation de certains produits ? Ce contexte orientera fortement vers une origine allergique. En recherchant dans les antécédents, est-ce qu'il y a des antécédents allergiques, tel par exemple un patient qui est suivi pour un eczéma atopique ou pour un asthme ou une conjonctivite allergique qui témoigne de la présence d'un terrain allergique chez le patient ? Est-ce qu'il y a la notion de traumatisme de la face, traumatisme crânio-facial, chirurgie nasale ou bien chirurgie du carbone ? Et bien sûr, rechercher une prise médicamenteuse, certains produits qui entraînent une obstruction nasale, une arénorée.

Il faut se méfier de l'utilisation des vasoconstructeurs au long cours. Savoir que les vasoconstructeurs utilisés de façon locale peuvent soulager le patient de ce symptôme qui est l'obstruction nasale. Mais lorsque ces vasoconstructeurs locaux sont utilisés anonymement, ils

entraînent un retentissement sur la muqueuse nasale avec le phénomène de dépendance et avec une hypertrophie décornée qui va apparaître et qui va être responsable d'obstruction nasale qui va être permanente.

Alors l'examen clinique, d'abord il faut essayer de faire le diagnostic positif de l'obstruction nasale, soit par l'épreuve de fermeture de la bouche si on a une obstruction nasale qui est bilatérale. Lorsqu'on ferme la bouche, le patient est très gêné en cas d'obstruction nasale complète. Ou bien faire le test de fermeture marine par marine, si on a une obstruction nasale droite et qu'on ferme la gauche, on va voir que le patient n'arrive plus à respirer par le nez.

Ou bien faire ce qu'on appelle l'épreuve instrumentale à l'aide d'un miroir, le miroir de Glanzel, qu'on met devant les deux orifices narinaires en demandant au patient de faire les inspirations et les expirations, normalement symétriques en regard des orifices narinaires. En cas d'obstruction nasale, on voit que les deux tâches de vie sont asymétriques, ou bien ils sont présents uniquement d'un côté et absents de l'autre côté qui est obstrué, ce qui témoigne d'une obstruction nasale complète. L'examen clinique comporte, comme mon avis pour l'arénoré, l'arénoscopie antérieure à l'aide du spéculum nasal, en essayant d'explorer le vestibule nasal, les fosses nasales, apprécier l'état de la muqueuse, est-ce qu'il est inflammatoire, les cornées, est-ce qu'ils sont hypertrophiées, rechercher une déviation de la cloison nasale.

Est-ce qu'il y a un corps étranger déjà visible, est-ce qu'il y a une tumeur, est-ce qu'il y a des polypes, est-ce qu'il y a des cicatrices, qu'on appelle des cynichies, en rapport avec une chirurgie précédente. Et bien sûr, puisque l'arénoscopie antérieure ne permet pas d'explorer toute la puce nasale, on va compléter soit par l'arénoscopie postérieure à l'aide d'une voile, qu'on va passer derrière la voile, ou bien faire une nasophibroscope qui va nous permettre d'explorer toute la muqueuse nasale. Alors, lors de l'exploration d'un patient qui a une obstruction nasale, il faudra faire l'examen d'abord sans mettre de vasoconstructeur local, c'est-à-dire sans décongestionner la muqueuse nasale, on essaiera de faire l'examen complet de la muqueuse, on recherchera une déviation, on recherchera une tumeur, on recherchera une tumeur ou bien des polypes, apprécier la taille des cornées, puisqu'on peut avoir une hypertrophie des cornées, et bien sûr on fera l'examen après mise en place d'un vasoconstructeur pour voir est-ce qu'il y a une décongestion nasale qui va permettre de faire l'examen de façon beaucoup plus approfondie au niveau des méas à la recherche d'une synergie associée de pathologie qui peut être cachée au niveau des méas.

Dans certains cas, on a besoin de faire des examens para-académiques basés essentiellement sur l'imagerie, soit faire un blondo ou bien essentiellement le scanner qui va permettre d'explorer toutes les qualités naso-sénusiennes. Les tests cutanés sont pratiqués si on suspecte une origine archéologique, et en présence d'une tumeur, on s'aidera d'une biopsie avec une étude histologique. C'est en sachant que certains types de tumeurs, lorsqu'on suspecte par exemple l'angiofibrome nasopharyngien chez l'enfant ou bien l'adolescent, la biopsie est contre-indiquée,

vu qu'il y a un risque important de séméon.

Alors quelles sont les étiologies des obstructions nasales ? En fait, elles sont réparties en fonction de l'âge. Chez le nouveau-né et surtout l'adolescent, c'est l'imperforation cunale. Alors, en présence d'une imperforation cunale bilatérale, le maître symptôme qui va la révéler, c'est la dysplée néonatale.

En cas d'imperforation immunitaire, dans ce cas-là, le diagnostic risque d'être fait de façon tardive, puisqu'il va se manifester par obstructions nasales. C'est une chose qui est difficile à mettre en évidence si on ne fait pas un examen systématique chez le nouveau-né, ce qu'on appelle l'épreuve à la sonde. C'est-à-dire qu'on va prendre une sonde d'aspiration, qu'on va passer à travers la fosse nasale, à droite puis à gauche, et voir si on arrive à voir la sonde au niveau de l'oropharynx.

C'est uniquement de cette façon qu'on pourra mettre et diagnostiquer l'imperforation cunale chez le nouveau-né. Sinon, lorsqu'elle est immunitaire, il risque de passer inaperçu, et le diagnostic va être fait tardivement, puisqu'on va remarquer qu'il y a une rhinorrhée périllante qui va apparaître, et puis il y aura une obstruction nasale qui va s'installer. Chez l'enfant, il faut toujours penser au corps étranger des fosses nasales, surtout devant une obstruction nasale immunitaire, une rhinorrhée périllante, d'installation récente et qui n'est pas chronique.

Pensez à une tumeur, certains types de tumeurs comme on l'a vu chez l'enfant, et bien sûr surtout chez le grand enfant à l'âge de la prépuberté. Pensez au fibromonasopharyngien, qui est une tumeur essentiellement fibrovasculaire, qui va se manifester par une obstruction nasale immunitaire progressive associée à des épistaxis, parfois de grande abondance. L'hépertrophie d'adhésation adénoïde, qui va se manifester surtout par des ronchements nocturnes associés à une obstruction nasale, parfois ça peut être responsable d'un syndrome d'apnée du sommeil avec des pauses respiratoires.

La nuit, cette hépertrophie risque de retentir sur la croissance faciale de l'enfant, sur son développement psychomoteur, et en même temps risque de retentir sur l'oreille moyenne en cas d'association à une rhinopharyngite chronique. Les rhinites, qu'elles soient d'origine allergique ou non allergique, peuvent être responsables d'obstructions nasales, et dans ce cas-là elles seront associées à d'autres signes, comme on l'a dit au début. L'arynorée, qui en général sont claires, bilatérales, associées à l'origine allergique à un éternuement, bien sûr lors de l'exposition aux allergènes.

Chez l'adulte, les histologies sont diverses, ça peut aller de la biviation de la cloison nasale, qu'elle soit post-traumatique ou bien congénitale, et dans ce cas-là le diagnostic peut être juste clinique lorsqu'on a une biviation qui est antérieure, ou parfois il faudra faire un examen endoscopique, voire demander à Scalera qui va montrer la biviation lorsqu'elle est antérieure. Mais la muqueuse dans ce cas-là, la muqueuse nasale, elle est intacte, elle est normale, et il n'y

a uniquement l'obstruction, et elle n'est pas associée à d'autres signes que l'arynorée, l'éternuement ou le fluide fondeur. Les tumeurs des forces nasales et du rhinopharynx, qu'elles soient bénignes ou malignes, peuvent être responsables d'obstruction nasale, et dans ce cas-là, il y aura d'autres signes associés que l'inépiastie bénigne, qu'elle soit antérieure ou postérieure, l'arynorée, furulente, mêlée à du sang, les céphalies, les adjus faciales, une exophtale, mais éventuellement en cas de tumeur ayant atteint un stade avancé.

Et bien sûr, il y a les rhinites, qu'elles soient allergiques ou non allergiques. Lorsqu'on est devant une rhinite allergique, il y a toujours cette notion d'obstruction nasale, à bascule, associée à l'éternuement, au fluide nasal, et bien sûr, avec la présence de luttas, de lieux et de temps. Alors ça, c'est un exemple de polyposis nasocénusienne, qui est responsable d'une obstruction nasale, d'une rhinorée claire en général.

Ça, c'est un patient qui a une déviation septale antérieure. Vous voyez ici la cloison nasale qui a une forme convexe du côté gauche, qui va obstruer la fosse nasale gauche, et être responsable d'une obstruction nasale permanente, unilatérale. Toujours l'exemple d'une déviation septale de la cloison nasale, vu sur le scanner.

Ça, c'est un scanner de la face en coupe frontale, appelée coupe coronale. Là, on voit la cloison nasale, qui doit être normalement verticale. Là, elle est déviée du côté gauche.

Là, c'est un patient qui se plaint d'une obstruction nasale bilatérale, et le scanner montre une hypertrophie importante du cornet inférieur, en rapport avec une limite chronique. Ça, c'est un exemple d'atrésie cronale bilatérale, surtout du côté gauche. Là, c'est un scanner qui est fait en coupe horizontale, dite axiale, où on voit l'obstruction nasale en rapport avec une atrésie cronale osseuse du côté gauche.

Là, c'est un patient qui présente une obstruction nasale droite, en rapport avec une tumeur de fosse nasale, et ce patient-là nécessitera un scanner avec une biopsie pour confirmer le diagnostic. Ce genre de tumeur se manifeste par une obstruction nasale d'installation progressive. Il n'y a pas de douleur au début.

Cette obstruction nasale peut se rattocier à une rhinorée claire, parfois purulente, avec parfois une épistaxis minime. Mais, avec l'évolution, on aura l'apparition de rhinorées purulentes, l'aggravation de l'obstruction nasale, l'apparition parfois d'algésie faciale, parfois même d'exopalmie. Et c'est le scanner ainsi que l'étude histologique ou anatomopathologique qui va confirmer le diagnostic.